

cli2-final

Aquí tienes las respuestas directas y los fundamentos de los temas evaluados.

Endocrinología

1. Cetoacidosis Diabética (CAD) vs. Estado Hiperosmolar No Cetósico (EHNC) Ambas son complicaciones agudas de la diabetes, pero difieren en su fisiopatología y laboratorio. La CAD marca una deficiencia absoluta de insulina (típico de DBT 1), mientras que el EHNC tiene suficiente insulina para evitar la lipólisis pero no la hiperglucemia severa (típico de DBT 2).

Parámetro	Cetoacidosis Diabética (CAD)	Estado Hiperosmolar (EHNC)
Glucemia	> 250 mg/dL	> 600 mg/dL
pH arterial	< 7.30 (Acidosis)	> 7.30 (Normal o leve)
Bicarbonato	< 18 mEq/L	> 18 mEq/L
Cetonas (suero/orina)	Positivas (Altas)	Negativas o trazas
Osmolaridad efectiva	Variable	> 320 mOsm/kg
Brecha Aniónica (Anion gap)	Elevada (> 12)	Normal o levemente elevada

Export to Sheets

2. Hipoglucemia

- **Definición:** Tríada de Whipple (Glucosa < 70 mg/dL + síntomas de hipoglucemia + resolución al normalizar la glucemia).
- **Causas:** Fármacos (Insulina, sulfonilureas), consumo de alcohol, insuficiencia hepática o renal severa, sepsis, insulinoma.
- **Tratamiento:** Paciente consciente: Regla de los 15g (15g de carbohidratos de absorción rápida vía oral, reevaluar en 15 min). Paciente inconsciente/grave: Dextrosa (Glucosa) hipertónica al 25% o 50% IV. Si no hay vía: Glucagón IM o SC.

3. Nódulo Tiroideo (Manejo) El objetivo es descartar malignidad.

1. Dosar TSH inicial.
2. **Si TSH es baja:** Pedir centellograma tiroideo. Si es un nódulo "caliente" (hipercaptante), la malignidad es rara.
3. **Si TSH es normal o alta:** Pedir Ecografía de cuello.
4. Según las características ecográficas (clasificación TI-RADS) y el tamaño, se decide si requiere Punción Aspiración con Aguja Fina (PAAF) para citología.

4. Hiperprolactinemia

- **Fisiológicas:** Embarazo, lactancia, estrés, coito.
- **Farmacológicas (muy frecuentes):** Antipsicóticos, metoclopramida, antidepresivos tricíclicos (bloquean la dopamina, que inhibe la prolactina).

- **Patológicas:** Prolactinoma (adenoma hipofisario), hipotiroidismo primario (la TRH alta estimula la prolactina), lesiones del tallo hipofisario.

5. Nefropatía Diabética (Diagnóstico) Presencia de albuminuria persistente (≥ 30 mg/g de creatinina en 2 de 3 muestras de orina aislada en un período de 3 a 6 meses) y/o reducción sostenida del Filtrado Glomerular (VFG < 60 mL/min/1.73 m²) en un paciente diabético, descartando otras causas de enfermedad renal.

6. Tirototoxicosis / Hipertiroidismo

- **Causas:** Enfermedad de Graves (autoinmune, más común), Adenoma tóxico (Plummer), Bocio Multinodular Tóxico, Tiroiditis (liberación transitoria).
- **Clínica:** Pérdida de peso, taquicardia, temblor, intolerancia al calor. (Exoftalmos y mixedema pretibial son exclusivos de Graves).
- **Laboratorio:** TSH suprimida, T3 y T4 libres elevadas.
- **Anticuerpos:**
 - **TRAB (Anticuerpos contra el receptor de TSH):** Estimulan el receptor. Son diagnósticos de Enfermedad de Graves.
 - **Anti-TPO (Antiperoxidasa):** Bloquean o destruyen. Clásicos de Hashimoto, pero pueden estar positivos en Graves.
- **Tratamiento:** Antitiroideos de síntesis (Metimazol), Betabloqueantes para los síntomas (Propranolol), Iodo radioactivo (I-131) o Cirugía (Tiroidectomía).

7. Diabetes (Diagnóstico) Criterios: 1) Glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL; 2) Glucemia ≥ 200 mg/dL a las 2 horas en la Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa (PTGO con 75g de glucosa anhidra disuelta en agua); 3) HbA1c $\geq 6.5\%$; 4) Síntomas clásicos + glucemia al azar ≥ 200 mg/dL. Los tres primeros requieren confirmación con una segunda prueba.

8. Enfermedad de Addison (Insuficiencia Suprarrenal Primaria)

- **Definición y Etiología:** Destrucción de la corteza suprarrenal con déficit de glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Causas: Adrenalitis autoinmune (más común globalmente) y Tuberculosis (muy frecuente en países en desarrollo).
- **Clínica:** Astenia profunda, pérdida de peso, hiperpigmentación cutáneo-mucosa (por exceso de ACTH/MSH), hipotensión.
- **Laboratorio:** Hiponatremia, hiperpotasemia.
- **Tratamiento:**
 - *Mantenimiento:* Hidrocortisona oral (15-25 mg/día divididos, ej: 15 mg mañana, 5 mg tarde) + Fludrocortisona (mineralocorticoide).
 - *Crisis Addisoniana:* Hidrocortisona 100 mg IV en bolo, seguido de infusión continua o 50 mg IV cada 6 horas + Reanimación agresiva con fluidos (Solución Fisiológica).

Reumatología

1. Dolor Mecánico vs. Inflamatorio Regla fundamental que exigen los profesores:

- **Mecánico:** Empeora con el movimiento/esfuerzo, mejora con el reposo. Rigidez matinal ausente o muy breve (< 30 min). Típico de artrosis o fibromialgia.
- **Inflamatorio:** Empeora con el reposo, mejora con el ejercicio. Rigidez matinal prolongada (> 1 hora). Despierta al paciente por la noche. Típico de AR, LES, EASP.

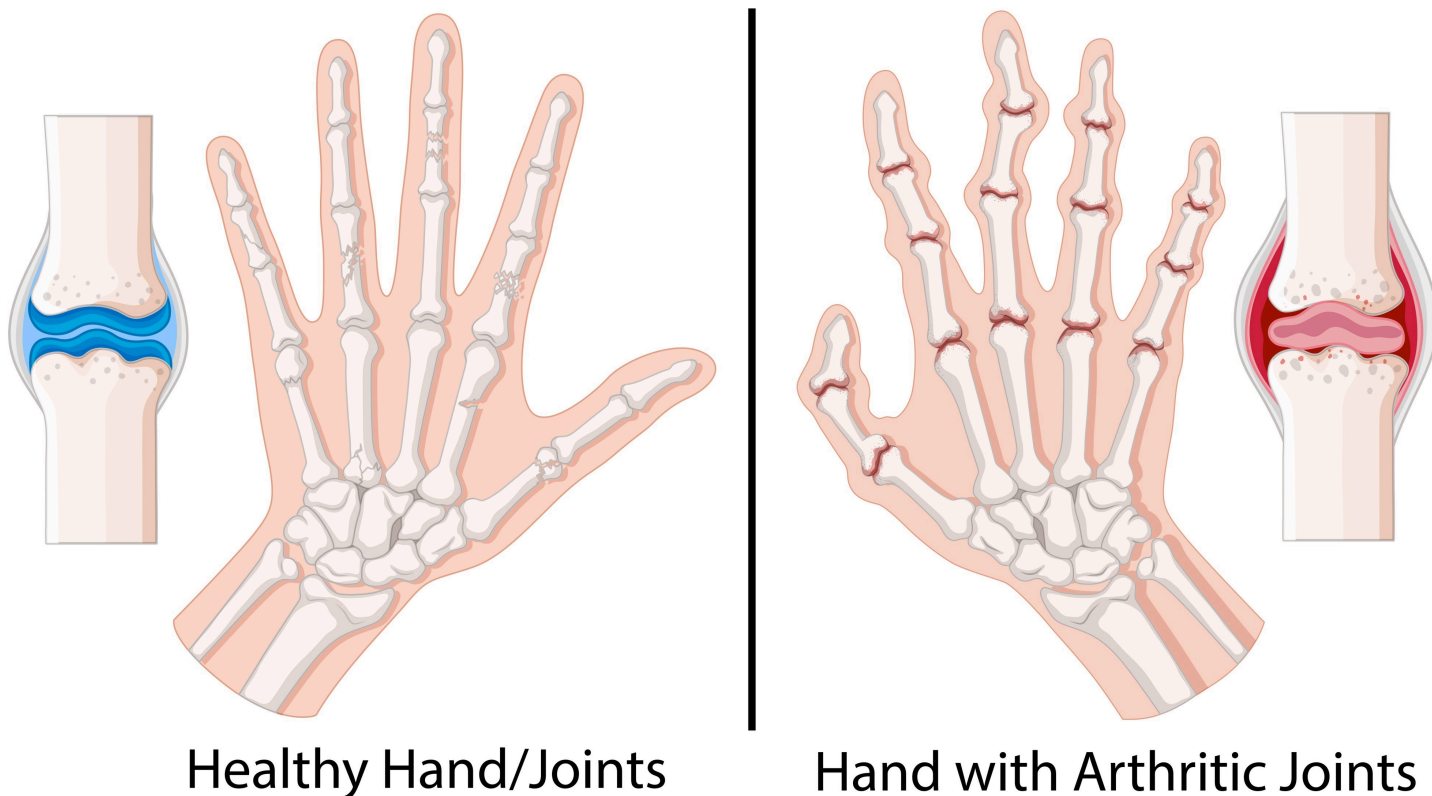
2. Polimialgia Reumática y Vasculitis

- **Definición/Clínica:** Síndrome inflamatorio en > 50 años. Dolor y rigidez severa en cinturas escapular y pelviana (cuello, hombros, caderas).
- **Laboratorio:** VSG y PCR muy elevadas.
- **Tratamiento:** Responde rápida y espectacularmente a corticoides a dosis bajas (Prednisona 15 mg/día). *Nota:* Se asocia fuertemente a la Arteritis de Células Gigantes (vasculitis de grandes vasos que requiere dosis altas de corticoides para evitar ceguera).

3. Artritis Reumatoide (AR): Radiografía

- **Agudos/Tempranos:** Aumento de partes blandas (derrame/sinovitis), osteoporosis yuxtaarticular (en bandas).
- **Crónicos/Tardíos:** Pinzamiento simétrico del espacio articular, erosiones óseas marginales, subluxaciones, anquilosis.

Rheumatoid Arthritis in Hand



Shutterstock

Explore

4. Lupus Eritematoso Sistémico (LES): Anticuerpos

- **ANA:** Screening. Alta sensibilidad, baja especificidad.

- **Anti-DNA doble cadena (dsDNA):** Alta especificidad. Correlaciona con la actividad de la enfermedad y riesgo de Nefritis Lúpica.
- **Anti-Sm:** Muy específico para LES, pero no correlaciona con la actividad.
- **Anti-Ro / Anti-La:** Asociados a Sjögren secundario, lupus cutáneo subagudo y lupus neonatal (bloqueo cardíaco congénito).
- **Nefritis Lúpica:** Se sospecha ante proteinuria (> 0.5 g/día), hematuria dismórfica o cilindros celulares en el sedimento de un paciente lúpico.

5. Terapia Biológica

- **Screening previo:** Descartar infecciones latentes. Excluir Tuberculosis (PPD/IGRA y Rx Tórax), Serologías para Hepatitis B, Hepatitis C y VIH.
- **Contraindicaciones:** Infección activa grave, TBC latente no tratada, Insuficiencia cardíaca severa (NYHA III/IV), antecedente de enfermedades desmielinizantes, neoplasias recientes.

6. Espondiloartropatías Seronegativas (EASP)

- **Características compartidas:** Factor Reumatoide y anti-CCP negativos (seronegativas), asociación con HLA-B27, afectación del esqueleto axial (sacroileítis, espondilitis), oligoartritis periférica asimétrica (predominio en miembros inferiores), entesitis (inflamación de la inserción tendinosa, ej: Aquiles) y dactilitis (dedos en salchicha).
- **Psoriásica:** Puede presentar oligoartritis, poliartritis simétrica (similar AR), afectación interfalángica distal, o mutilante. Diagnóstico por criterios CASPAR (Psoriasis actual/previa/familiar, distrofia ungueal, dactilitis, neoformación ósea yuxtaarticular en Rx, FR negativo).

7. Fibromialgia

- Dolor crónico generalizado de tipo funcional/mecánico. No hay inflamación periférica; es una alteración del procesamiento central del dolor.
- **Diagnóstico:** Clínico. Uso del Índice de Dolor Generalizado (WPI) y la Escala de Gravedad de Síntomas (SS). Laboratorio estrictamente normal.
- **Tratamiento:** Ejercicio aeróbico graduado (pilares). Fármacos neuromoduladores: Amitriptilina, Duloxetina, Pregabalina. No responden a AINEs ni corticoides.

8. Dermatomiositis y Esclerodermia

- **Dermatomiositis:** Lesiones cutáneas patognomónicas: Pápulas de Gottron (placas eritemato-violáceas descamativas sobre las prominencias óseas, principalmente nudillos e interfalángicas). Eritema en heliotropo (párpados).
- **Esclerodermia (Síntomas iniciales):** Fenómeno de Raynaud (presente en casi el 100% y precede por años a la enfermedad) y fase edematosa de las manos ("puffy hands").

9. Diagnóstico Diferencial Articular

- **Monoartritis (4 causas):** Artritis séptica (infecciosa), Gota (cristales de urato), Pseudogota (pirofosfato cálcico), Hemartrosis/Traumática.
- **Poliartritis (4 causas):** Artritis Reumatoide, Lupus (LES), Artritis Psoriásica (forma poliarticular), Poliartritis viral (Ej: Parvovirus B19, Hepatitis B/C).

10. Osteoporosis

- **Causas farmacológicas:** Glucocorticoides (> 3 meses es la causa secundaria más frecuente), Inhibidores de la Bomba de Protones (IBP) crónicos, Anticonvulsivantes (fenitoína), Heparina.
-

Neumonología

1. Asma

- **Crisis severa (Tratamiento):** Oxígeno (mantener SatO₂ > 90%). Broncodilatadores de acción corta: SABA (Salbutamol) + SAMA (Ipratropio) nebulizados o con aerocámara a altas dosis. Corticoides sistémicos tempranos (Meprednisona oral o Hidrocortisona IV). Si no hay respuesta: Sulfato de Magnesio IV.
- **4 cosas a evaluar antes de subir escalón terapéutico (Mal manejo):** 1) Mala adherencia al tratamiento. 2) Técnica inhalatoria incorrecta (error más común). 3) Exposición ambiental continua a alérgenos/tabaco. 4) Comorbilidades no tratadas (RGE, rinosinusitis, obesidad).
- **Espirometría en asma:** Patrón obstructivo (VEF1/CVF < 0.70) que **revierte** con el uso de broncodilatadores (aumento del VEF1 en ≥ 12% y ≥ 200 mL).

2. EPOC

- **Qué valorar (Estadificación GOLD):** Severidad de la obstrucción (VEF1 en espirometría), carga de síntomas (escala mMRC o CAT) y riesgo de exacerbaciones (historial de internaciones/crisis previas).
- **Vacunas:** Antigripal anual, Antineumocócica (esquema secuencial), VSR, COVID-19 y Tos ferina (dPaT).
- **Tríada de Anthonisen (Exacerbación):** 1) Aumento de la disnea, 2) Aumento del volumen del esputo, 3) Aumento de la purulencia del esputo. Requiere antibiótico si hay purulencia + otro criterio.
- **Tto exacerbación con sospecha de Pseudomona:** Quinolonas respiratorias a altas dosis (Levofloxacina o Ciprofloxacina) o betalactámicos con acción antipseudomónica (Piperacilina-Tazobactam).

3. Hemoptisis

- **Definición:** Expectoración de sangre proveniente del tracto respiratorio inferior (subglótico).
- **Causas:** Bronquiectasias, Bronquitis crónica, Cáncer de pulmón, Tuberculosis.
- **Medidas generales (Masiva/Amenazante):** Reposo a 45 grados. Posicionar al paciente en decúbito lateral sobre el pulmón que sangra (para evitar inundar el pulmón sano). Oxigenoterapia. Colocación de vías venosas periféricas gruesas para reanimación. **Intubación Orotraqueal (IOT):** Crítico para asegurar la vía aérea y aspirar, ya que la principal causa de muerte es la asfixia, no el shock hipovolémico. Si es posible, intubación selectiva del pulmón sano.

4. Derrame Pleural

- **Criterios de Light (Diferencia trasudado de exudado):** Es un exudado si cumple al menos UNO de estos tres: 1) Proteínas en pleura / Proteínas en suero > 0.5. 2) LDH en pleura / LDH en suero

> 0.6. 3) LDH en pleura > 2/3 del límite superior normal en suero.

- **Causas de Exudado:** Infecciones (paraneumónico, TBC), Neoplasias, TEP, Autoinmunes.
- **Líquido Pleural (pH y glucosa):** Si el pH es bajo (< 7.20) y la glucosa es baja (< 60 mg/dL), sugiere un **Empiema** (derrame paraneumónico complicado), artritis reumatoide, TBC o neoplasia.
- **Tratamiento del Empiema:** Drenaje con tubo de avenamiento pleural (imprescindible) + Antibióticos sistémicos.

5. SAHOS (Síndrome de Apneas-Hipopneas del Sueño)

- **Factores de riesgo:** Obesidad (principal), alteraciones maxilofaciales (retrognatia), cuello ancho (>43 cm en hombres), consumo de alcohol, uso de benzodiacepinas/sedantes.
- **Tratamiento leve:** Descenso de peso, higiene del sueño, evitar decúbito supino al dormir, evitar sedantes y alcohol nocturno. Dispositivos de avance mandibular. (El CPAP se reserva para casos moderados a severos).

6. Tromboembolismo Pulmonar (TEP)

- **Electrocardiograma:** Lo más frecuente es la taquicardia sinusal. El patrón más específico (pero raro) para sobrecarga de cavidades derechas es el **S1Q3T3** (Onda S en DI, Onda Q en DIII, Onda T invertida en DIII).
- **5 Factores de riesgo mayores:** 1) Cirugía mayor reciente (especialmente ortopédica de cadera/rodilla o oncológica abdominal). 2) Traumatismo mayor/fractura de huesos largos. 3) Inmovilización prolongada o reposo en cama. 4) Cáncer activo. 5) TEP o TVP previa.

7. Espirometría y TAC

- **Contraindicaciones Espirometría:** Infarto Agudo de Miocardio (IAM) reciente (< 1 mes), cirugía ocular reciente (riesgo por aumento de presión intraocular), aneurisma aórtico o cerebral inestable, neumotórax reciente.
- **Nódulo Pulmonar (4 signos de malignidad en TAC):** Bordes espiculados (corona radiada), tamaño mayor a 8-10 mm, calcificaciones asimétricas o excéntricas, localización predominante en lóbulos superiores, cavitación con pared gruesa.
- **Bronquiectasias:** Colonización bacteriana crónica se define por el aislamiento de un mismo microorganismo patógeno en dos o más cultivos de esputo separados por al menos 3 meses durante un período de 1 año.